

医療 AI の倫理 — 知っておきたい 6 つのチェックポイント

全スタッフ向け（10 分）

AI が「この患者さん、危ないです」と言ったら、皆さんどうしますか？

今日のゴール：AI を安全に使うための「6 つのチェックポイント」を知り、
自分の仕事に 1 つ当てはめられるようになる

医療の世界での AI 活用の現在地

場面	AI の役割	例
画像診断	レントゲン・CT の異常検出	胸部 X 線の肺結節スクリーニング
予測	急変・再入院リスク予測	敗血症早期警告システム
投薬	薬物相互作用チェック	処方オーダーの自動アラート
業務支援	書類作成・要約	退院サマリーの下書き

AI は「道具」であり、最終判断は必ず人間が行います

6つのチェックポイント

世界の研究 22 件から見えてきた倫理的課題（Wubineh et al., 2026）

1. 透明性と信頼

AI がなぜそう判断したか、分かるか？

2. 偏り（バイアス）と公平性

全ての患者さんに同じように正確か？

3. プライバシー

患者さんのデータは守られているか？

4. 責任の所在

間違いがあったら誰が責任を取るか？

5. 道徳的な問題

AI に任せていいことの線引きは？

6. 法律とルール

法整備は追いついているか？

具体例で理解しよう — 「偏り（バイアス）」って何？

皮膚科の AI が「良性です」と判断。
しかしこの AI は、明るい肌トーンの画像データで主に訓練されていた。
結果： 暗い肌トーンのお患者さんでは、皮膚がんを見逃すリスクが上昇。

- AI は訓練に使ったデータの特徴を学ぶ
- データに偏りがあると、特定の患者さんで精度が下がる
- 高齢者、少数民族、農村部の住民はデータが少ないことが多い

あなたの職場では： 導入された AI が「どんなデータで訓練されたか」を確認する習慣が大切

グループ対話（3分） — 「うちの職場なら？」

「もし自分の職場に AI が導入されたら、
6つのチェックポイントのうち、どれが一番気になる？」

職種	考えるヒント
看護師	AI アラートと患者さんの訴えが食い違ったら？
薬剤師	AI 処方チェックを過信して見落とすリスクは？
リハビリ	AI 推奨と患者さんの意欲のバランスは？
事務	患者データが AI に使われることの説明は？
医師	AI の推奨を採用 / 却下した根拠をどう記録する？

世界と日本の動き — ルールはどう変わっていくか

EU（ヨーロッパ）

- EU AI 法 2026 年 8 月適用開始
- 医療 AI = 高リスク AI → 技術文書・人間の監視義務化
- スタッフの AI リテラシー教育も義務（2025 年 2 月～）

日本

- AI 推進法 2025 年成立
- 厚労省 医療データ AI 利活用ガイドライン運用中
- 2026 年度診療報酬改定で AI・ICT 活用推進

「AI を使えること」だけでなく「AI を安全に使えること」が求められる時代へ

今日のまとめと明日からのアクション

6つのチェックポイント：透明性 / 偏り / プライバシー / 責任 / 道德 / 法律

看護師

AI アラートが出たとき「なぜ？」と1回聞く習慣

薬剤師

AI 処方チェックを「ダブルチェックの1つ」として位置づける

リハビリ

AI 提案を参考にしつつ、患者さんとの対話を最優先に

事務

患者さんから AI 質問→担当者につなぐ窓口を確認

医師

AI 推奨と判断が異なるとき、理由をカルテに一言メモ

「AI を怖がる」のではなく「AI と上手につきあう」。
その第一歩が、今日の6つのチェックポイントです。